

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	癲癇的照護 Care of Epilepsy				
編號	A31000-Q03-W-A13	制定者	R12 林碧嵐	公布日期	105 年 08 月 05 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 09 月 03 日
版本/總頁數	第 1.7 版/10 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解癲癇的原因、症狀、影響、常見治療、護理問題與措施以及衛教指導，使具備更適切之照護能力，以提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

癲癇是一種慢性、陣發性的疾病，癲癇發作是因為大腦細胞不正常放電所引起的，每次的發作通常會持續數十秒到 2-3 分鐘。

（二）原因

容易引起癲癇發作的因素有：過度呼吸、閃光刺激（例如：電視、電腦）、情緒不佳壓力大、月經導致賀爾蒙改變、睡眠不足、突然減藥或停藥、短時間內體重改變太大、持續腹瀉、服用某些藥物、血糖及電解質變化、感冒、喝酒、感染發燒等，所以必須避免以上誘因，以減少癲癇發作的次數。

（三）症狀

1. 最常見的癲癇有全身型僵直陣攣性發作又稱為癲癇大發作、複雜型部分性癲癇發作、及失神性發作（又稱為癲癇小發作）。當癲癇症狀發作時，病人可能會有一段時間意識喪失，有的病人完全喪失意識，有的則是部分喪失。
2. 全身型僵直陣攣性癲癇發作時，病人會突然喪失意識、仆跌倒地、可能喉中有聲，但是四肢僵直、呼吸短暫中止、臉發黑、可能咬傷唇舌而流血。陣攣階段：

主題名稱	癲癇的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A13	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	2/10

肌肉抽搐與鬆弛的現象交替出現，四肢呈現陣發性痙攣、可能咬到頰內或舌頭而流血。

3. 複雜型部份性癲癇發作時，病人會呈現意識混亂、對周遭的知覺遲緩、漫無意識的「自發性動作」(如：踱步、搓手、拉扯衣服、咂嘴、做咀嚼動作)、若意圖壓制，病人可能會掙扎。失神性發作(小發作)時病人會發作過程非常短暫，瞬間即逝(約 5 至 12 秒)、喪失意識僅數秒鐘，有時會誤以為病人在做白日夢、可能木然呆視、眨眼、臉部扭曲、病人通常不會仆跌倒地，對周遭一切毫無感覺，常見於六到十四歲的兒童。

(四) 常見檢查

1. 腦電波：確認異常放電的位置及確認診斷，及辨明抽搐發作的類別。另用於懷疑有抽搐發作的篩檢。
2. 顱骨 X 光檢查及電腦斷層檢查：顯示有無頭部創傷、出血、腦室大小、大腦皮質有無萎縮等，這些病變均可能導致抽搐發作。
3. 正子電腦斷層掃描攝影：協助確立癲癇病灶的位置。

(五) 常見治療

1. 美國 2000 版嚴重頭部外傷處理指導原則建議：腦部的灌流壓應該維持於 60 - 70mmHg，外傷初期應維持至少 70mmHg 以預防腦部缺血情形及維持顱內壓正常。
2. 避免引起癲癇發作的原因：減少或去除引起癲癇發作的原因，以控制癲癇發作的次數。
3. 使用抗癲癇藥物：每天按時服用抗癲癇藥物，不要隨便減藥或停藥，以減緩癲癇發作的次數。
4. 開刀治療：約有 10%的癲癇病人，因為無法用藥物控制癲癇發作，可以經由神經專科醫師評估，選擇開刀的治療方式。

(六) 常見處理

1. 全身型僵直陣攣性癲癇發作：

主題名稱	癲癇的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A13	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	3/10

- (1) 避免病人受傷病人即將仆跌時，拿一件柔軟衣物協助病人躺下使用。取下眼鏡並鬆開緊貼的衣物，在癲癇發作剛開始時，卸下病人的假牙。
- (2) 移動病人身體時，不要拉手臂，要推動軀體，免得肩關節脫臼。勿強壓病人，癲癇發作通常會很快結束，如果強壓著病人，可能會傷及病人（肌肉拉傷或骨折）。
- (3) 病人意識恢復時，必須有人在身邊，讓病人心理可以安定。發作過後，病人若仍處於意識混亂的狀態，請勿急忙要求站立或行走。
- (4) 絕對禁止塞任何東西進入病人嘴巴，或強迫撬開病人口腔或塞入東西的動作，因為造成的損傷，可能大過於癲癇本身所引起的傷害。
- (5) 假如病人仰臥著，協助維持呼吸道通暢，當發作結束之後，就可以把病人維持側臥姿勢，因為舌頭會後倒向喉頭，堵住了呼吸。側臥姿勢也可以讓蓄積的口水從口腔向外流，若有嘔吐應協助清理病人的呼吸道，以免吸入窒息，發作時或剛剛發作完畢，勿讓病人吞食任何流質飲食，因這可能使病人哽住或噎到。

2. 複雜型部份性癲癇發作：

- (1) 請陪伴病人。
- (2) 輕柔協助以免導致病人傷害他人，因為病人可能掙扎反抗不要試圖阻擋他，讓發作順其自然的過去並陪伴病人，直到他的意識完全恢復為止。

3. 失神性發作

- (1) 不需要任何急救措施，但是病人有過癲癇發作的情形，一定要讓醫療人員及家人知道，並注意安全。

（七）護理問題

1. 易跌倒/抽搐發作有關
2. 呼吸道清除功能不良/與抽搐發作、意識喪失有關
3. 社交互動困難/身體心像改變、情境性低自尊有關

主題名稱	癲癇的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A13	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	4/10

(八) 護理措施

1. 易跌倒/抽搐發作有關

- (1) 病人臥床時使用床欄並注意床欄穩固。
- (2) 降低病床高度。
- (3) 使用夜燈的設置。
- (4) 使用防滑墊、穿著止滑鞋。
- (5) 清除病床到浴室間障礙物，保持地面乾燥及適當照明。
- (6) 護理人員每 2 小時查看病人情形。
- (7) 將尿壺或便盆放置可以拿取位置。
- (8) 教導病人及家屬瞭解目前行動能力及限制，採漸進式活動，且須有人在旁扶助。
- (9) 教導病人使用叫人鈴並置於適當位置，以方便拿取。
- (10) 讓病人及家屬瞭解正在服用易導致跌倒的藥物，如：降血壓及安眠藥等。
- (11) 衛教病人在服用藥物後半小時內改變姿勢宜緩慢。
- (12) 必要時依醫囑給予適當的約束。
- (13) 依照顧者國籍給予預防跌倒照護單張。

2. 呼吸道清除功能不良/抽搐發作

- (1) 將病人擺放至最佳通氣位置。
- (2) 床旁備妥口腔人工氣管、抽吸設備、氧氣，必要時進行抽吸。
- (3) 協助病人躺下，頭部側向一邊，使口腔中分泌物流出，以維持呼吸道通暢，鬆開過緊的衣物，勿做口對口人工呼吸，以免將嘔吐物吹入肺部造成窒息，需要時進行抽吸及給予氧氣。
- (4) 評估呼吸狀況，紀錄呼吸型態、咳嗽和痰的變化。
- (5) 維持呼吸道通暢，切勿塞任何東西到口中，或硬把咬緊的牙齒撬開。
- (6) 必要時給予氧氣。
- (7) 監測意識狀況。

主題名稱	癲癇的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A13	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	5/10

(8) 監測生命徵象。

3. 社交互動困難/身體心像改變、情境性低自尊有關

(1) 探討病人的價值觀與治療建議不一致之處並檢視特定衝突為何。

(2) 醫療人員與家屬/病人共同討論修正治療建議，彼此對疾病認同一致。

(3) 解釋該疾病徵象、症狀和危險因子，和病人目前的經驗比較。

(4) 評估並記錄病人服藥的態度。

(5) 給予藥物衛教，使瞭解服用藥物可能引起之副作用，如有副作用出現予立即性處理，以增進對服用藥物之順從性。

(6) 指出病人服藥後改善之處，引導病人將病情改善與規則服藥作連結，以增進病識感。

(7) 解釋與治療建議有關的原則和程序並鼓勵病人與醫師討論自己的病情及藥物使用。

(8) 一起討論治療的好處，強調這些治療對維持或重建健康及安適有何助益。

(九) 衛教指導

1. 預防跌倒須知。

2. 認識癲癇與照護。

(1) 誘發癲癇發作的原因：腦部某種病變或傷害存在。如疤痕（頭部外傷、腦膜炎）、腦膿瘍（細菌感染化膿）、腦瘤（不明原因），先天性畸形（動靜脈畸形），腦部先天發育障礙，腦中風（腦血管阻塞或出血）皆可，全身代謝障礙（低血糖、內分泌失調、缺氧等及部份特異性體質（不明原因者，此部份可能與遺傳較有關係）。

(2) 癲癇發作之醫療處置：若有徵象、症狀發生時，應立即保持冷靜，持續記錄癲癇發作之時間及性質，待發作結束，視情況就醫，若持續嚴重情形，進行相關檢查：腦部電腦斷層、磁共振造影、EEG、生化或血液等多項檢查。

主題名稱	癲癇的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A13	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	6/10

3. 飲食須知

- (1) 均衡的飲食：定時定量，足夠的維他命、纖維質（因為便秘、嚴重的腸脹可能增加發作的次數）。
- (2) 避免過多的刺激性飲料：例如：酒、咖啡、茶（因為具有興奮神經細胞的作用）。
- (3) 避免瞬間大量的喝水：每 4~5 小時內喝水不超過 800~1200CC，因過多的水分造成腦水腫與低血鈉會引發癲癇發作。
- (4) 足夠的維他命 B6 的攝取：含有 B6 的食物包括：深綠色的蔬菜、豆製品（四季豆）、花生堅果類、腰果等。

4. 生活日常須知

- (1) 癲癇獲得良好控制病人，醫師會允許病人到游泳池或海水浴場游泳，不過身邊要有人陪伴才行。另外可進行騎腳踏車、網球、籃球、足球等規則運動，但在參與任何活動前，最好先請教主治醫師並事先告知主辦單位，以作事先防範。
- (2) 最好能避免任何發作時會導致對病人或別人造成危險的事，例如：駕駛飛機或攀岩潛水之類的活動。另外須經過一段足夠長的時間沒有發作後才可以開車（國內法律規定「患有癲癇的人不能考駕駛執照」）。
- (3) 基本原則就是應該儘量避免參與有危險性的活動，如爬高、水裡活動、器械競技，同時也不可處於危險的環境，如：身在高處、機械房、深水邊危險樓梯間等地方。

5. 藥物須知

- (1) 治療癲癇時，應儘量避免合併使用其他藥物（如：感冒藥、止痛藥、抗生素、鎮靜劑等）。
- (2) 服用抗癲癇藥物時，應避免與其他藥物（如：胃藥）一起服用，抗癲癇藥很少會傷胃，即使空腹也可以吃藥。已有胃潰瘍，則服用胃藥時，最好與抗癲癇藥物相隔 2 小時。

主題名稱	癲癇的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A13	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	7/10

- (3) 應避免與牛奶、飯一起服用，相互須間隔二小時以上，因為食物可能會影響有些藥物的吸收效果，導致血中抗癲癇藥物濃度降低。
- (4) 按時服藥，切勿忘記服藥，常常忘記，則會降低治療效果或導致復發。
- (5) 服用抗癲癇藥物的初期，有些人想睡或噁心的現象，若是從小的劑量開始，逐漸增加藥量，在服用一段時間後（身體適應後），這些現象都可以獲得改善，血中也可以達到有效的治療藥物濃度。
- (6) 服用抗癲癇藥物最忌「突然中止」服藥，也不可以因為發作而自行增加藥量，因為突然停藥，可能致使血中濃度下降而發生重複發作，即所謂的「癲癇重積狀態」。自行調藥有些會發生副作用或導致癲癇控制不理想，所以調整藥量必須依據血中藥物濃度及發作次數評估後行之。
- (7) 不要迷信偏方、祖傳秘方或成分不明的成藥。
- (8) 服用藥物發生過敏時，如：起紅疹、發燒、口腔潰爛等現象，此時應暫停服藥，並立即回診就醫。需注意過敏可能在 1-2 個月後才發生。

(十) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 陳龍(2021)・2021年台灣腦中風學會與台灣癲癇醫學會之中風後癲癇治療指引・台灣中風醫誌2021, 167-193。
- (二) 美國神經外科醫學會與腦外傷基金(2000)・嚴重頭部外傷處理之指引 [Guidelines

主題名稱	癲癇的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A13	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	8/10

for the management of severe head injury] • 取自

<https://www.neurosurgery.org.tw/nsr/tbi/main.htm>

(三) Zelano J, Holtkamp M, Agarwal N, et al. (2020)How to diagnose and treat post-stroke seizures and epilepsy. *Epileptic Disord*;22:252-263. doi: 10.1684/epd.2020.1159.

(四) Hardtstock F, Foskett N, Gille P, et al.(2021)Poststroke epilepsy incidence, risk factors and treatment: German claims analysis. *Acta Neurol Scand*;143:614-623. doi: 10.1111/ane.13403.

七、附件

(略)

主題名稱	癲癇的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A13	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
105.08.05	1.0	新制定	105 年 08 月 05 日護理部照護標準委員會通過；105 年 08 月 05 日公布
106.08.31	1.1	第三項第(三)目部份內容修辭	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八目之 3(6)(7)內容說明修訂	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.07.24	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	1.3	第三項第十目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	1.4	1. 第三項第九目之 3(1)(2)合併於之 2；(3)說明內容刪除。 2. 第三項第九目之 6(4)說明文字修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	1.5	1. 第三項第七目、第八目護理問題及護理措施內容部份修辭潤飾。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。

